Panduan dewasa ZMC

Diabetes tipe 2: makan lebih teratur, kenali gejala samar, rawat kaki, dan jangan telat kontrol

Diabetes tipe 2 sering datang pelan, jadi gejala awal, pola makan, kaki, dan kontrol perlu dicek rutin.

Jangan tunggu parah
haus, kencing lebih sering, atau cepat lelah patut dicek

Kontrol itu bagian terapi
HbA1c dan evaluasi rutin membantu cegah komplikasi terlambat

Ringkasnya: gejala awal diabetes tipe 2 sering samar, makan perlu pakai prinsip *3J* dan *Isi Piringku*, kaki harus dicek harian, dan kontrol jangan menunggu keluhan berat.

1) Gejala awal: sering samar, kadang baru ketahuan setelah gula lama tinggi

Konteks: WHO menulis gejala diabetes tipe 2 bisa ringan dan butuh waktu lama untuk disadari. Langkah praktis: kenali pola keluhan harian, bukan satu gejala saja. Kapan evaluasi medis: kalau ada gejala berulang, riwayat keluarga, berat badan berlebih, atau gula darah pernah tinggi, jangan menunda cek.

Keluhan yang paling sering muncul adalah **lebih haus, lebih sering kencing, cepat lelah, penglihatan kabur, dan berat badan turun tanpa sengaja**. CDC juga memasukkan rasa lapar yang meningkat, infeksi yang lebih sering, serta luka yang lama sembuh sebagai gejala yang patut dicurigai.

Di lapangan, pasien sering bilang, "Saya cuma sering pipis malam," atau "Akhir-akhir ini mata suka buram kalau sore." Masalahnya, gejala seperti ini gampang dianggap sepele. Padahal kalau gula darah lama tinggi, saraf, pembuluh darah, ginjal, dan mata bisa ikut terdampak.

- Kalau sering haus dan kencing tetapi minum manis juga sering, jangan mengandalkan perasaan "masih kuat". Tetap perlu cek gula darah.
- Kalau badan cepat capek, mudah mengantuk, kesemutan, atau luka kecil di kaki tidak cepat membaik, pikirkan diabetes sebagai salah satu kemungkinan.
- Kalau ada riwayat keluarga diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas, atau lingkar perut besar, ambang untuk periksa harus lebih rendah.

3 sinyal awal yang patut dicurigai

1. Haus dan kencing lebih sering

terutama malam hari atau terasa tidak seperti biasa

2. Cepat lelah dan pandangan kabur

jangan tunggu sampai aktivitas harian terganggu

3. Luka lambat sembuh atau infeksi berulang

misalnya bisul, jamur, gatal lipatan, atau lecet kaki

Yang sering disebut "3P"

Polidipsia = banyak minum, **poliuria** = sering kencing, **polifagia** = cepat lapar. Di Kemenkes, pola ini masih sering dipakai sebagai tanda akut yang perlu dicurigai.

Kenapa sering telat ketahuan?

Karena diabetes tipe 2 bisa berjalan bertahun-tahun dengan gejala ringan. WHO menekankan diagnosis dini penting agar komplikasi berat tidak jadi "alarm pertama".

Kapan sebaiknya cek darah?

Bila usia di atas 45 tahun, ada berat badan berlebih, riwayat keluarga, hipertensi, kolesterol tinggi, pernah gula naik saat medical check-up, atau muncul gejala di atas lebih dari beberapa hari.

Catatan penting: kadar gula yang sangat tinggi juga bisa muncul sebagai **mulut kering, pusing, napas cepat, napas berbau tidak biasa, atau penurunan kesadaran**. Ini bukan pola "ditunggu sampai besok", tetapi perlu evaluasi segera.

2) Diet: bukan sekadar "jangan manis", tetapi atur 3J dan isi piring lebih rapi

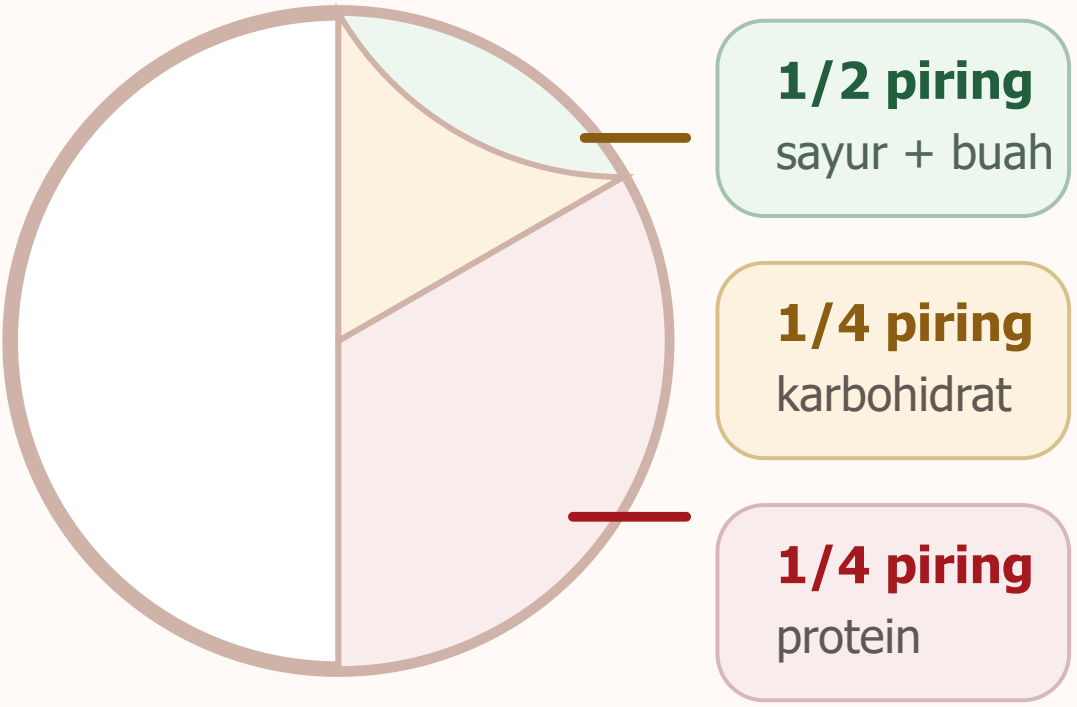
Konteks: pengaturan makan adalah salah satu pilar utama terapi diabetes. Langkah praktis: pegang prinsip **3J** yaitu jadwal, jumlah, dan jenis, lalu terjemahkan ke menu rumahan yang realistis. Kapan evaluasi medis: kalau masih bingung porsi, gula tetap tinggi, sering lapar berlebihan, atau berat badan turun tanpa direncanakan.

Prinsip **3J** dari Kemenkes membantu pasien supaya gula darah tidak naik turun terlalu liar. **Jadwal** berarti makan lebih teratur, **jumlah** berarti porsi tidak asal tambah, dan **jenis** berarti lebih memilih makanan tinggi serat, lebih sedikit gula bebas, garam, dan lemak jenuh.

Kalau masih sering makan besar sekaligus lalu lama tidak makan, gula darah bisa lebih sulit stabil. Karena itu, banyak pasien lebih cocok dengan pola **3 kali makan utama + 2 sampai 3 selingan kecil bila perlu**, terutama bila memakai obat tertentu atau insulin.

Kemenkes lewat **Isi Piringku** mengingatkan bahwa setiap kali makan, **setengah piring diisi sayur dan buah**, sedangkan sisanya diisi makanan pokok dan lauk. Untuk pasien diabetes, prinsip ini membantu menahan porsi karbohidrat agar tidak mendominasi satu piring.

Piring yang lebih aman tiap makar



Minuman utama: air putih. Minuman manis cukup dibatasi ke bukan jadi teman makan harian.

Jadwal

- Usahakan jam makan tidak terlalu maju-mundur.
- Jangan menebus lapar dengan makan besar sekaligus.
- Bila mudah hipoglikemia atau pakai insulin, diskusikan pola selingan dengan dokter atau ahli gizi.

Jumlah

- Porsi karbohidrat tetap ada, tetapi jangan mendominasi hampir seluruh piring.
- Lauk dan sayur membantu kenyang lebih lama daripada minuman manis.
- Kalau berat badan berlebih, pengurangan porsi perlu dilakukan pelan tetapi konsisten.

Jenis

- Pilih lebih sering: sayur, buah utuh, tahu, tempe, telur, ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan.
- Batasi: minuman manis, kue manis, gorengan berulang, santan pekat, daging berlemak, makanan ultra-proses.
- WHO menganjurkan lebih banyak pangan segar, whole grain, legum, buah, dan sayur.

Makan / minum	Lebih sering dipilih	Perlu dibatasi	Catatan praktis
Nasi dan sumber karbohidrat	**Ada, tapi terukur**	-	Nasi tetap boleh. Bedanya ada di porsi. Bisa selang-seling dengan jagung, kentang, ubi, atau nasi campur beras lebih tinggi serat.
Teh manis, kopi sachet, minuman botol, boba	-	**Batasi ketat**	Kalau setiap hari, minuman sering justru lebih cepat menaikkan gula dibanding makanan.
Lauk Sunda rumahan	**Sering**	-	Pepes ikan, tahu, tempe, ayam ungkep panggang, sayur asem ringan, tumis tipis minyak lebih baik daripada serba goreng dan serba kuah santan kental.
Buah	**Utuh, bukan jus**	**Jus manis**	Pepaya, jambu, apel, jeruk, pir, dan belimbing umumnya lebih mudah dikendalikan porsinya bila dimakan utuh.
Camilan	**Pilih cermat**	**Jangan asal**	Pilih kacang tanpa gula berlebih, telur rebus, buah, atau tahu kukus. Keripik manis-asin dan biskuit sering membuat porsi kebablasan.

Contoh modifikasi yang tetap terasa "makan rumah"

- Nasi secukupnya + pepes ikan + lalapan + sayur bening.
- Nasi + tumis buncis tipis minyak + tahu/tempe + pepaya.
- Bila ingin sambal, buat lebih segar dan kurangi gula atau kecap manis berlebihan.
- Kalau terbiasa "wajib minum manis", mulai dari kurangi frekuensi dulu, bukan menunggu niat sempurna.

Yang perlu diingat: CDC menegaskan tidak ada satu "diet diabetes" yang harus seragam untuk semua orang. Intinya adalah makan sehat yang lebih rendah gula tambahan, lemak jenuh, dan sodium, dengan pola yang sesuai budaya makan keluarga.

3) Kaki diabetik: luka kecil bisa jadi masalah besar kalau telat terlihat

Konteks: gula yang lama tinggi dapat merusak saraf dan aliran darah, sehingga kaki lebih mudah mati rasa, lecet, dan susah sembuh. Langkah praktis: cek kaki tiap hari dan rawat kulit dengan cara yang aman. Kapan evaluasi medis: bila ada lecet, kemerahan, bengkak, kuku bernanah, luka, atau perubahan warna.

Checklist cek kaki harian

Checklist ini disimpan di perangkat ini supaya tetap berguna saat file dibuka offline.

- [ ] Saya sudah melihat telapak, sela jari, tumit, dan punggung kaki hari ini. Bila sulit, pakai cermin atau minta bantuan keluarga.
- [ ] Tidak ada luka, lecet, lepuh, kapalan yang berubah, kulit pecah, atau kuku yang tumbuh ke dalam.
- [ ] Saya cuci kaki dengan air hangat suam-suam kuku, bukan air panas, lalu dikeringkan sampai sela jari.
- [ ] Saya pakai pelembap tipis di kulit kaki yang kering, tapi tidak mengoleskan di sela jari.
- [ ] Saya tidak berjalan tanpa alas kaki dan sudah cek bagian dalam sepatu atau sandal sebelum dipakai.
- [ ] Bila ada kelainan baru, saya tidak mengobati sendiri dengan cairan kapalan atau memecahkan lepuh.

Kapan risiko kaki makin besar?

1. **Gula sulit stabil.**
   CDC menulis kadar gula yang sering tinggi meningkatkan risiko kerusakan saraf.
2. **Sudah lama diabetes.**
   Semakin lama perjalanan penyakit, makin besar peluang saraf dan aliran darah ikut terganggu.
3. **Ada mati rasa atau riwayat luka.**
   Kalau kaki terasa baal, pasien bisa tidak sadar sedang menginjak benda tajam atau sepatu terlalu sempit.

CDC menganjurkan **cek kaki setiap hari**, cuci dengan air hangat **bukan panas**, pakai pelembap di permukaan kaki tetapi **jangan di sela jari**, dan **jangan berjalan tanpa alas kaki** bahkan di dalam rumah.

Kuku sebaiknya dipotong **lurus**. Kapalan, mata ikan, atau kuku tumbuh ke dalam **jangan dikorek sendiri** dan jangan pakai obat kapalan bebas sembarangan karena bisa membakar kulit. Bila penglihatan kurang baik, badan tidak fleksibel, atau tangan gemetar, lebih aman minta bantuan tenaga kesehatan.

- Sepatu harus pas, tidak sempit, dan tidak longgar. Bagian dalam sepatu perlu dicek apakah ada kerikil atau lipatan.
- Kalau kaki sering kering dan pecah, pelembap boleh dipakai tipis setelah mandi.
- Bila ada jamur sela jari, bau menyengat, kemerahan, atau kuku berubah kuning dan tebal, periksa lebih awal.

Jangan tunggu jadwal kontrol berikutnya bila ada luka, lepuh, kuku bernanah, warna kaki berubah menjadi lebih pucat atau kebiruan, atau kaki bengkak dan terasa hangat. Pada pasien diabetes, masalah kecil di kaki bisa memburuk cepat.

4) Kapan kontrol? Patokannya bukan cuma saat merasa keluhan muncul

Konteks: kontrol rutin dipakai untuk menilai apakah gula darah benar-benar aman dan apakah komplikasi mulai muncul diam-diam. Langkah praktis: pahami ritme harian, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Kapan evaluasi medis: lebih cepat bila obat berubah, gula belum tercapai, sedang sakit, atau ada masalah kaki.

Setiap hari

- Cek gula darah mandiri sesuai anjuran dokter, terutama bila pakai insulin atau obat yang bisa menyebabkan gula turun.
- Cek kaki tiap hari untuk melihat luka, lecet, kemerahan, bengkak, atau perubahan kuku.
- Minum obat sesuai resep walau sedang merasa "baik-baik saja".

Setiap 3 bulan

- **HbA1c** bila terapi baru diubah atau target gula belum tercapai.
- Kontrol dokter lebih rapat bila masih sering tinggi, sering hipoglikemia, berat badan turun, atau ada luka kaki.
- Bawa catatan gula darah, obat, dan keluhan yang muncul di rumah.

Setiap 6 bulan

- CDC menyarankan kontrol dan HbA1c **setiap 6 bulan** bila target sudah tercapai dan pengobatan stabil.
- Tekanan darah, berat badan, kepatuhan obat, dan pola makan tetap perlu ditinjau.
- Untuk banyak pasien dewasa, target HbA1c awal biasanya **sekitar 7% atau kurang**, tetapi bisa diindividualkan.

Setiap tahun

- Pemeriksaan mata dengan pupil dilatasi.
- Pemeriksaan fungsi ginjal dan urine albumin.
- Kolesterol dan pemeriksaan kaki lengkap, lebih sering bila pernah ada masalah kaki.

Situasi	Kontrol yang disarankan	Apa yang biasanya dinilai	Kenapa penting
Baru didiagnosis atau obat baru diubah	**Lebih rapat**	Gejala, gula darah rumah, efek samping obat, pola makan, tekanan darah, berat badan	Bila respons terapi belum stabil, penyesuaian obat dan edukasi perlu dilakukan lebih cepat.
Gula belum mencapai target	**Sekitar 3 bulan**	HbA1c, kepatuhan minum obat, risiko hipoglikemia, kebiasaan makan dan aktivitas	CDC menaruh HbA1c tiap 3 bulan bila target belum tercapai.
Gula sudah stabil	**Sekitar 6 bulan**	HbA1c, tekanan darah, berat badan, obat, keluhan baru	Stabil bukan berarti bebas kontrol. Komplikasi tetap bisa berjalan tanpa gejala jelas.
Pernah ada masalah kaki atau baal	**Lebih sering**	Pemeriksaan kaki di tiap kunjungan, dan foot exam lengkap minimal tahunan atau lebih rapat	CDC menyarankan cek kaki lebih sering pada pasien yang pernah bermasalah.

Patokan praktis: bila gula masih sering tinggi, ada obat baru, atau keluhan baru muncul, anggap kontrol berikutnya **lebih dekat ke 3 bulan**. Bila sudah stabil dan target tercapai, banyak pasien bisa kontrol berkala **sekitar 6 bulan** sesuai keputusan dokter.

5) Catatan untuk kondisi khusus

Konteks: target kontrol dan pola makan tidak selalu sama untuk semua pasien. Langkah praktis: beri tahu dokter bila ada penyakit lain, usia lanjut, atau sedang puasa. Kapan evaluasi medis: bila kebiasaan makan berubah drastis, sering gula turun, atau fungsi ginjal menurun.

Usia lanjut dan mudah gula turun

Target gula dan HbA1c bisa dibuat lebih individual. Prioritasnya bukan sekadar angka serendah mungkin, tetapi **aman, tidak sering hipoglikemia, dan tetap mampu makan serta bergerak**.

Penyakit ginjal, jantung, atau stroke

Jangan atur obat sendiri. Beberapa obat diabetes perlu penyesuaian bila fungsi ginjal berubah. Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan ginjal menjadi makin penting.

Puasa, nafsu makan turun, atau sedang infeksi

Jadwal makan dan obat bisa berubah. Bila sedang puasa atau sakit, diskusikan lebih dulu, karena beberapa pasien justru berisiko hipoglikemia atau gula melonjak saat demam dan dehidrasi.

Beri tahu dokter bila: sedang memakai steroid, sedang hamil atau merencanakan hamil, sering muntah, sulit makan, ada alergi obat berat, atau pernah pingsan karena gula terlalu rendah. Informasi ini mengubah keputusan terapi.

6) Kapan harus ke dokter atau IGD?

Bagian ini sengaja dibuat tegas. Jangan menunggu jadwal rutin bila muncul tanda bahaya berikut.

Kontrol lebih cepat di klinik / dokter

- Gejala awal diabetes muncul berulang: haus, sering kencing, cepat lelah, mata kabur.
- Angka gula rumah sering tinggi beberapa hari berturut-turut.
- Luka kecil di kaki belum membaik dalam 1-2 hari, walau belum berat.
- Berat badan turun tanpa sengaja atau nafsu makan berubah jelas.

Periksa hari ini, jangan ditunda

- Kaki merah, bengkak, bernanah, bau, atau nyeri baru muncul.
- Mati rasa, kesemutan berat, atau kaki terasa sangat panas atau sangat dingin.
- Gula darah sangat tinggi disertai mulut kering, pusing, atau pandangan kabur.
- Sering gula turun, gemetar, keringat dingin, atau hampir pingsan setelah minum obat.

Segera ke IGD

- Gula darah **300 mg/dL atau lebih** menetap, apalagi disertai muntah, tidak bisa minum, atau napas cepat.
- Napas berbau buah, sangat lemas, mengantuk berat, bingung, atau penurunan kesadaran.
- Luka kaki cepat meluas, kulit menghitam, bengkak berat, atau demam tinggi.
- Nyeri dada, sesak, wajah mencong, bicara pelo, atau kelemahan separuh badan.

Patokan aman: bila Anda ragu apakah ini masih bisa ditunggu, lihat kondisinya dari **minum masih bisa atau tidak, sadar penuh atau tidak, dan ada luka kaki aktif atau tidak**. Pada diabetes, keterlambatan beberapa jam kadang lebih berisiko daripada datang "terlalu cepat".

7) FAQ singkat

Pertanyaan yang paling sering muncul saat baru tahu gula darah tinggi atau saat mulai bosan diet.

Apakah pasien diabetes tidak boleh makan nasi sama sekali? +

Kalau gula sudah turun, boleh berhenti kontrol? +

Apakah herbal bisa menggantikan obat diabetes? +

Mata kaki lecet sedikit, apa cukup diobati sendiri? +

8) Rujukan

Sumber dipilih dari lembaga resmi dan terbaru yang relevan dengan edukasi pasien per 10 Maret 2026.

1. WHO. Diabetes Fact Sheet. Diperbarui 14 November 2024.
2. WHO. Healthy Diet Fact Sheet. Diperbarui 26 Januari 2026.
3. CDC. Symptoms of Diabetes. Diperbarui 15 Mei 2024.
4. CDC. Your Feet and Diabetes. Diperbarui 15 Mei 2024.
5. CDC. Your Diabetes Care Schedule. Diperbarui 15 Mei 2024.
6. CDC. A1C Test for Diabetes and Prediabetes. Diperbarui 15 Mei 2024.
7. Kemenkes RI. Isi Piringku: Pedoman Makan Kekinian Orang Indonesia. 13 Desember 2022.
8. Kemenkes RI Ditjen Keslan. Prinsip 3J Penderita Diabetes. 13 Oktober 2022.
9. Kemenkes RI Ayo Sehat. Mengenal Penyakit Hiperglikemia. 17 November 2022.
10. Kemenkes RI Ditjen Keslan. Berdampingan Hidup Dengan Si Manis. 27 Juli 2022.
11. PERKENI. Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2024.

Kalau masih bingung mulai dari mana, bawa halaman ini saat kontrol

Yang paling membantu biasanya justru sederhana: catat gula darah, tulis obat yang dipakai, foto luka kaki bila ada perubahan, lalu tunjukkan saat konsultasi.

Buka Maps

Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu - layanan 24 jam untuk keluarga Wanaraja dan sekitarnya.

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

Telepon: +62 822-1718-0432

Jam: Senin - Minggu: 24 Jam

Kontak dan lokasi

WhatsApp

Maps

Instagram

Tip offline: simpan file ini satu folder dengan `zmc-logo.jpeg` agar logo tetap tampil saat dibuka langsung dari perangkat.

© 2026 Zihan Medical Center - Wanaraja Garut

Materi edukasi pasien. Bukan pengganti pemeriksaan langsung.